2.5.6 获益与风险评估

目　　录

2.5.6.1 治疗背景 2
2.5.6.2 获益 2
2.5.6.3 风险 3
2.5.6.4 获益风险评估 4

2.5.6.1 治疗背景

小细胞肺癌（SCLC）占所有肺癌病例的 15-20%，无论从组织来源、生物学特征、对治疗的反应和预后等方面都与非小细胞肺癌迥然不同，所以被认为是一种全身性的疾病。SCLC 侵袭性高，预后较差，5 年生存率不足 5%，不治疗的患者平均生存期仅 2~4 个月。大多数 SCLC 患者在初诊时失去了根治性治疗机会，但是联合化疗仍是广泛期 SCLC 的有效治疗方法，可以改善症状，延长生存期。广泛期 SCLC 一线化疗缓解率为 40%~70%，中位生存期为 7~11 个月。尽快初始化疗缓解率高，但多数完全缓解的患者在 3 个月内病情进展，远期疗效差。EP 方案是治疗广泛期 SCLC 的一线标准治疗方案。在临床应用中，为了减轻胃肠道反应、肾毒性和神经毒性，通常用卡铂替代顺铂，但卡铂的骨髓造血功能抑制风险较顺铂更大。

对于广泛期 SCLC 一线治疗，也进行很多其它联合化疗方案的临床研究，但均未取代标准治疗方案。2019 年 3 月，基于 IMpower133 研究结果，FDA 批准 Atezolizumab 联合化疗用于广泛期 SCLC 一线治疗。IMpower133 研究是一项观察 Atezolizumab 联合 EC 一线治疗广泛期 SCLC 的双盲、随机、安慰剂对照研究。入组了既往未接受过治疗的广泛期 SCLC 患者，不要求进行 PD-L1 检测。患者 1:1 随机分配接受 4 个周期的卡铂+ 依托铂苷联合 Atezolizumab 或安慰剂，21 天为一个治疗周期，然后给予 Atezolizumab 或安慰剂维持治疗，直至疾病进展、不可耐受的毒性或不再有临床获益。共同主要终点为 OS 和研究者评估的 PFS。研究结果提示，Atezo 组相对安慰剂组显著延长 SCLC 患者的 mOS、mPFS，两组 OS 分别为 12.3 vs 10.3 个月，mPFS 分别为 5.2 vs 4.3 个月[3]。

CASPIAN 研究是一项关于广泛期 SCLC 患者一线治疗的随机、开放、全球多中心的Ⅲ期临床试验，旨在探索 Durvalumab 和 Tremelimumab 联合化疗在广泛期 SCLC 患者一线治疗中的疗效。该研究纳入了初治的广泛期 SCLC 患者，使用 Durvalumab±Tremelimumab 联合 EP 方案（依托泊苷+顺/卡铂类）化疗。主要研究终点为总生存期(OS)。最终，相较于单纯化疗组的 OS（10.3 个月），Durvalumab 联合化疗组的 OS 达到了 13.0 个月（HR=0.73，p=0.0047），降低 27%的死亡风险。单纯化疗组的 12 个月 OS 率为 39.8%，而 Durvalumab 联合化疗组为 53.7%，提高了 13.9%。单纯化疗组的 ORR 为 57.6%，Durvalumab 联合化疗组为 67.9%，提高了 10.3%[4]。2020 年 3 月，基于 CASPIAN 研究结果，FDA 批准 Durvalumab 联合化疗用于广泛期 SCLC 一线治疗。

2.5.6.2 获益

盐酸安罗替尼胶囊 ALTER1202 研究（ALTN-12-II）采用随机（2:1）、双盲、安慰剂对照、多中心设计，入组经病理学确诊的、复治（既往接受过至少 2 种化疗方案）的晚期小细胞肺癌患者。研究实际入组 120 例受试者，截止 2018 年 6 月 30 日，安罗替尼组和安慰剂组的中位 PFS 分别为 4.07 月（95%CI：2.79-4.24）和 0.72 月（95%CI：0.69-0.82），与安慰剂相比，安罗替尼可使小细胞肺癌患者的中位 PFS 延长 3.35 月，肿瘤复发风险降低 80.8%，差异有显著统计学意义（HR=0.192，95%CI 0.117~0.315，p<0.0001）。截止 2018 年 6 月 30 日，明确死亡的终点事件共 53 件（44.54%），其中安慰剂组 21 件（55.26%），安罗替尼组 32 件（39.51%）。安罗替尼组和安慰剂组的中位 OS 分别为 7.29 月（95%CI 为 6.50-10.51）和 4.90 月（95%CI 为 2.56-6.67），两组间有统计学差异（p=0.021）。基于本研究结果，CDE 于 2019 年 8 月 29 日有条件批准安罗替尼用于既往至少接受过 2 种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌的治疗。

2020 年 ASCO 公布一项安罗替尼联合依托泊苷、顺铂/卡铂一线治疗广泛期小细胞肺癌的单臂、II 期临床研究（摘要号 9066）。主要终点为 PFS 和 ORR。推荐剂量如下：安罗替尼 12mg QD（连二停一）、依托泊苷（100mg/m^2,d1-3/d21）、顺铂（75-80mg/m^2,Q3W）、卡铂（AUC=5-6，Q3W）。安罗替尼联合化疗 4-6 周期后，单药使用安罗替尼维持。截止 2018 年 10 月至 2019 年 12 月，合计入组 27 例患者，mPFS=9.61 个月（95% Cl:7.80-11.42），ORR=77.78%（21/27），DCR=96.3%（26/27）。安全性方面，≥3 级不良事件包括中性粒细胞计数降低（22%）、手足皮肤反应（15%）、白细胞计数降低（11%）、恶心（4%）、口腔黏膜炎（4%）等。本研究证实安罗替尼联合化疗一线治疗广泛期小细胞肺癌显著改善中位无进展生存期和客观缓解率，安全性可耐受，未见非预期不良事件。

TQB2450-Ib-04 研究是一项评估 TQB2450 联合安罗替尼治疗晚期实体瘤患者的 Ib 期临床试验，入组经标准治疗失败或无标准治疗方法的晚期实体瘤。TQB2450 固定剂量 1200 mg，安罗替尼进行 10 mg/qd、12 mg/qd 等剂量组爬坡。最终确定联合用药安全剂量为安罗替尼 12 mg/qd，d1-14/Q3W +TQB2450 1200mg，d1。本试验 2019 年 6 月启动，合计入组 22 例受试者，其中 6 例为既往接受过至少 2 种化疗方案的晚期小细胞肺癌。截止 2020 年 4 月 10 日，整体肿瘤客观缓解率 ORR 为 32.8%，DCR 为 81.8%，6 例 SCLC 患者的 ORR 为 66.7%，DCR 为 83.33%。本试验同时提示 TQB2450 联合安罗替尼有良好的耐受性和安全性，总体不良事件可控。

2.5.6.3 风险

TQB2450 注射液是未上市药品，但单药治疗的安全性和耐受性良好，不良反应以各类

检查异常为主，符合疾病特征，不良反应谱与同类药物不良反应基本一致；严重程度主要为 1-2 级，总体不良事件可控。

目前 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊已开展的 5 项 Ib 期临床研究已纳入的 229 例受试者，不良反应以各类检查异常为主，严重程度主要为 1-2 级，符合基础疾病的特征。3 级及以上不良反应发生率目前仅为 14.29%，主要为掌跖红肿综合征、心电图 QT 间期延长、高甘油三酯血症、高血压、腹泻等。TQB2450 联合安罗替尼的使用，并未出现不良反应叠加，耐受性良好，总体不良事件可控，且未发生非预期不良事件。

2.5.6.4 获益风险评估

盐酸安罗替尼胶囊自 2018 年上市以来，已获批 3 项适应症，疗效确切，安全可靠。TQB2450 注射液处于临床研究阶段，已开展多项单药或联合盐酸安罗替尼胶囊的临床试验，对多个瘤种初显疗效，安全性良好。基于已上市 PD-L1 单抗的临床经验，以及 TQB2450 注射液单药及联合盐酸安罗替尼胶囊的多项早期临床试验，本次申报具有足够的安全性数据支持。

TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊已经在非小细胞肺癌、肝细胞癌、胆道癌、软组织肉瘤、三阴性乳腺癌、卵巢癌、软组织肉瘤、恶性黑色素瘤等多个瘤种中开展了探索性临床研究，对多个瘤种初显疗效。2020ASCO 公布的 27 例安罗替尼联合化疗一线治疗广泛期小细胞肺癌的 II 期研究结果，也证实安罗替尼联合化疗一线治疗 SCLC 的初步疗效和安全性。

安罗替尼药品注册批件的要求（2019 年 8 月 29 日，批件号 2019S00491/2/3）如下：“请开展确证性研究 TQB2450-III-04，递交阶段性研究报告及总结报告，将在达到主要终点后转为完全批准”。TQB2450 注射液或安慰剂联合盐酸安罗替尼胶囊和依托泊苷/卡铂对比依托泊苷/卡铂一线治疗广泛期小细胞肺癌的随机、双盲、平行对照、多中心 III 期临床试验（方案编号：TQB2450-III-04）正在全国开展，第一例患者 2020 年 3 月 18 日随机入组，截止 2021 年 7 月 28 日，本试验已入组 576 例患者。

本次拟申请开展 TQB2450 或安慰剂联合安罗替尼+依托泊苷+卡铂对比依托泊苷+卡铂一线治疗广泛期小细胞肺癌的随机、双盲、平行对照、多中心 III 期临床试验。TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊药物组合的临床价值值得进一步开发，患者从此联合治疗中的获益值得期待。